

KC桌面——外资精译

全球医疗保健：制药业：肺癌关键意见领袖对ASCO进展总体持积极态度

在美国临床肿瘤学会（ASCO）会议之后，我们邀请了两位肺癌关键意见领袖（KOL）讨论关键更新，特别是MRK/科伦的sac-TMT在NSCLC中的optiTROP-05试验、SMMT/康方生物的ivonescimab+化疗一线治疗鳞状NSCLC的单区域（中国）III期HARMONi-6总生存期结果，以及对AZN、BNTX/BMY和PFE相关项目的解读。

讨论的主要结论包括：1) sac-TMT强劲的PFS获得好评，KOL对其安全性和毒性管理能力持乐观态度，同时指出最终的全球总生存期（OS）数据对于指导治疗决策至关重要；2) ivo相比Tevimbra（抗PD-1，类似于MRK的Keytruda）的OS获益具有临床意义，尽管KOL承认在老年患者中的疗效存在争议，并指出需要在全局III期HARMONi-3研究中得到确认，他们预计该研究鳞状队列最终PFS分析在下半年具有较高的成功概率；3) 对于AZN的Datroway，虽然注意到其开发领先地位，但KOL认为基于中国数据，sac-TMT在疗效和安全性方面具有潜在优势，但这有待全球试验验证。KOL还强调了他们在肺癌领域关注的新方法，包括三特异性抗体（PD1xCTLA4xVEGF）和RAS抑制剂。

主要结论

在美国临床肿瘤学会（ASCO）会议期间，我们与两位KOL进行了交流：1) 约翰霍普金斯大学医学院和都柏林圣三一大学的肿瘤学教授，以及2) 斯坦福大学的肿瘤学助理教授兼医学主任，讨论会议上的关键非小细胞肺癌（NSCLC）数据。约翰霍普金斯大学的KOL是一位胸部肿瘤内科医生，每年接诊约200名患者，几乎全部为NSCLC，其中约70%为非鳞状、25%-30%为鳞状，专注于早期免疫治疗试验。斯坦福大学的KOL是一位肿瘤内科医生，接诊大量NSCLC患者，此前曾在纪念斯隆凯特琳癌症中心和丹娜-法伯癌症研究所从事胃肠道癌和黑色素瘤的研究。

我们强调以下讨论的主要结论：

■ 当前1L mNSCLC患者管理。两位医生首先检查是否存在可靶向的基因突变，如果没有，则根据PD-L1表达水平和组织学类型（鳞状/非鳞状）决定治疗方案。对于PD-L1 TPS $\geq 50\%$ 的患者，一位KOL倾向于Keytruda单药治疗，而另一位则倾向于Keytruda联合化疗，因为他认为这能提供最佳缓解机会。对于TPS低于50%的患者，两位均使用Keytruda联合化疗，化疗方案根据组织学类型确定。

对MRK合作伙伴科伦的sac-TMT OptiTROP-Lung05数据的总体印象。

从疗效和安全性角度来看，一位KOL指出sac-TMT组的表现令人印象深刻（这是他见过的少数几个PFS HR如此显著的药物之一，同时承认Keytruda单药治疗并非全球范围内的相关对照组），并且毒性比化疗稍高，因此他关注可能对某些患者造成问题的AE，如口腔炎和间质性肺病，但总体乐观认为全球试验将取得阳性结果。另一位KOL指出Keytruda组似乎表现不佳，且OS有改善趋势，并称sac-TMT组约5%的停药率非常出色。sac-TMT毒性特征。聚焦于目前已知的安全性数据，一位KOL指出其特征似乎与AZN的Dato-DXD相似，并指出根据他使用ADC的经验，患者的个体反应和/或耐受能力可能差异很大。另一位KOL指出，当他与患者讨论ADC时，会预期出现类似化疗的副作用，并认为这些副作用是可控的，同时他表示感到鼓舞的是没有看到独特的副作用（肺炎、眼部问题等）。■ sac-TMT疗效特征。从疗效角度来看，KOL一致认为所有组均显示出获益，其中PD-L1高表达组的相关性最明确（鉴于Keytruda单药治疗对照组），因为有些患者更适合选择Keytruda单药治疗。临床决策的基准。一位KOL用棒球术语解释了他如何解读HR：优于0.85为一垒安打，约0.7至约0.85为二垒安打，约0.5至约0.7为三垒安打，低于0.5为本垒打，同时还会考虑曲线形态，旨在引导患者选择生存获益更高的方案——对于下一组sac-TMT数据，他将寻找HR为0.7至0.8且缓解率为65%至70%的数据，以取代标准治疗，并指出Keytruda专利将于2028年到期，这可能会增加（保险公司）使用该药物的压力。另一位KOL大致同意，但他认为ADC更适用于非鳞状疾病，而PD1xVEGF适用于鳞状疾病——对于OS，他指出要达到统计学显著性，HR通常需低于0.8

，并认为具有临床意义的HR基准为0.75。对SMMT合作伙伴康方生物的HARMONi-6 OS数据的总体印象。KOL指出，SMMT及其合作伙伴康方生物的PD1xVEGF双特异性抗体ivonescimab (ivo) 在III期HARMONi-6研究中相比Tevimbra (ONC的抗PD-1，类似于MRK的Keytruda) 联合化疗所显示的总生存期 (OS) 获益具有临床意义，表明ivo是一种有效的疗法，且无进展生存期 (PFS；HR=0.60) 与OS (HR=0.66) 之间的下降幅度相对较小。然而，他们承认全体会议讨论环节中关于年龄>65岁亚组缺乏获益的争论（见管理层评论此处），并警告说这项仅在中国进行的研究需要在全人群（通常包括老年患者）中重复验证。

此外，NSCLC中因吸烟和其他因素导致的区域病理生理学差异是可能的，这进一步支持了全球验证的必要性。在安全性方面，KOL强调HARMONi-6纳入了因血管包绕而出血风险较高、传统上不适合VEGF治疗的患者，指出ivo相对较少的VEGF介导毒性（高血压、出血）是其与贝伐珠单抗的区别，而免疫介导的毒性与Keytruda相似。

HARMONi-6 结果向全球 HARMONi-3 研究的转化。关于 HARMONi-6 结果向 SMMT 全球 III 期 HARMONi-3 一线 NSCLC 研究的转化，KOL 认为下半年鳞状 HARMONi-3 队列的最终 PFS 结果可能是积极的，因为 HARMONi-6 及其他适应症（例如在 ASCO 上分享的全球 II 期结直肠癌数据）中 ivo 的总体积极数据表明疗效信号是真实的。在讨论仅针对鳞状 NSCLC 的 HARMONi-6 数据向非鳞状 NSCLC 的解读时（回顾：全球 III 期 HARMONi-3 研究包含一个鳞状和一个非鳞状 NSCLC 患者队列），KOL 指出鳞状 NSCLC 通常更同质化，在吸烟者中患病率更高，因此根据现有数据，鳞状患者预期获益更大，并指出两种组织学之间的解读有限。总体而言，KOL 认为 ivo 可能优于 Keytruda，并等待全球 III 期 HARMONi-3 研究的数据以明确获益程度。

在比较双特异性抗体的 NSCLC 数据时，包括 BNTX/BMY 的 pumitamidg 和 PFE 的 PF'4404 在 ASCO 上的报告，KOL 指出从仅中国数据到全球数据，疗效下降极小，且数据总体支持 PD1/L1xVEGF 这一类别。KOL 还强调了有前景的新方法，包括中国生物技术公司基石药业 (CStone Pharmaceuticals) 的三特异性 PD1xCTLA4xVEGF 分子 CS2009。

KOL 强调了 AZN 的 Datroway 的开发领先地位，同时承认基于中国数据，sac-TMT 在疗效和安全性方面具有潜力，但有待全球试验验证。KOL 强调了 Datroway 的开发领先地位，指出其单药疗法已获 FDA 批准且临床经验成熟，这简化了医生将 Datroway 与 IO 疗法联合方案整合到其治疗流程中。在承认基于当前中国数据 sac-TMT 可能具有更优疗效及其在这些试验中低停药率的同时，KOL 强调这些结果需要在全全球研究中得到验证。关于 AVANZAR 试验，生物标志物策略被认为是合理的，Datroway 显示出优于培美曲塞的潜在疗效。然而，选择 Imfinzi 而非 Keytruda 作为对照组引入了风险。

KOL 正在关注的肺癌新方法。在新兴治疗模式方面，KOL 强调了多种“新-新”联合方案的潜力，包括 ADC + IO、双特异性抗体、三特异性抗体 (PD1xCTLA4xVEGF)，并指出 RAS 抑制剂是一个值得关注的领域（包括将这些药物与 IO/ADC 联合使用）。

估值与风险

MRK（买入）。估值：我们基于 (Q5-Q8) 调整后每股收益的 14.0 倍市盈率，得出 12 个月目标价 137 美元。下行风险：Keytruda LOE 侵蚀速度快于预期 / 转换为 Keytruda 皮下制剂的比例低于预期。成熟疫苗产品进一步放缓，新产品上市速度慢，以及监管不确定性。管线资产令人失望。与疫苗、FDA、关税及并购相关的监管/市场环境比预期更严峻。

SMMT（买入）。估值：我们的 12 个月目标价 41 美元基于混合 85%/15% 的风险调整 DCF 估值 35 美元 (WACC 18%，TGR 2%) 和理论并购价值 73 美元 (2031 年预期销售额的 11 倍)。下行风险：临床、技术和制造风险——合作伙伴康方生物在中国产生的数据可能无法转化至 SMMT 的全球临床研究；中美贸易关系可能对供应链运营产生不利影响；意外的安全性问题或临床延迟可能推迟上市时间表。监管风险——未能获得适应症或地区的监管批准可能影响商业成功，并对我们的销售预测构成重大下行风险。竞争风险——竞争对手的 PD-1/L1xVEGF

资产可能展示出更优数据，或临床开发进展快于预期。融资风险/稀释。

阿斯利康（买入）：我们的 12 个月目标价源自 DCF 和市盈率的 50:50 混合。我们的自下而上 DCF 分析表明每股估值为 15,912 便士（WACC 8.0%；TGR 2.5%），基于倍数法，我们认为阿斯利康应按 2027 年预期每股收益的 20 倍交易，得出每股估值 17,318 便士。因此，我们的目标价为每股 16,525 便士/219 美元。我们观点和目标价的主要风险：(i) 临床试验失败；(ii) 商业执行；(iii) 定价；(iv) 竞争发展；以及 (v) 专利风险。

公众号：KC桌面